

VASOATIVOS	INOTRÓPICOS
VASOPRESSORES	
Noradrenalina (0,010 – 2,000 mcg/kg/min) 4 amp (32 mg / 16 mL) + SG5% 234 mL → Total: 2500,3 – 65,6 mL/h 8 amp (64 mg / 32 mL) + SG5% 218 mL → Total: 2500,2 – 32,8 mL/h 4 ampolas (8 mg / 4 mL) + SG5%/SF 180 mL = 200 0,4 – 84,0 mL/h 8 ampolas (8 mg / 4 mL) + SG5%/SF 160 mL = 200 0,2 – 42,0 mL/h 1ª linha choque distributivo. ⚠ Não misturar com bicarbonato. ⚠ Extravasamento = necrose.	Dobutamina (2,50 – 20,00 mcg/kg/min) 1 amp (250 mg / 20 mL) + SG5%/SF 230 mL → Total: 10,5 – 250 mL (1 mg/mL K:16.6) 84,0 mL/h 2 amp (500 mg / 40 mL) + SG5%/SF 210 mL → Total: 5,3 – 250 mL (2 mg/mL K:33.3) 42,0 mL/h 3 amp (750 mg / 60 mL) + SG5%/SF 190 mL → Total: 250 mL (3 mg/mL) 3,5 – 28,0 mL/h 2 amp (500 mg / 40 mL) + SG5%/SF 60 mL → Total: 2,1 – 16,8 100 mL (5 mg/mL) mL/h 3 ampolas (250 mg / 20 mL) = 750 mg em 60 mL → 0,8 – 6,7 12500 µg/mL mL/h Escolha no choque cardiogênico. ⚠ Pode piorar hipotensão no choque distributivo.
Vasopressina (0,010 – 0,040 UI/min) 1 amp (20 UI / 1 mL) + SF 0,9% 99 mL → Total: 3,0 – 12,0 100 mL (0,20 UI/mL) mL/h 2 amp (40 UI / 2 mL) + SF 0,9% 98 mL → Total: 1,5 – 6,0 100 mL (0,40 UI/mL) mL/h 2ª linha no choque distributivo refratário. Dose usual: 0,03 UI/min.	Dopamina (2,00 – 20,00 mcg/kg/min) 5 amp (250 mg / 50 mL) + SG5%/SF 200 mL → Total: 8,4 – 250 mL (1 mg/mL K:16.6) 84,0 mL/h 10 amp (500 mg / 100 mL) + SG5% 150 mL → Total: 4,2 – 42,0 250 mL (2 mg/mL) mL/h 5 ampolas (50 mg / 10 mL) = 250 mg em 50 mL → 1,7 – 16,8 5000 µg/mL mL/h Efeito dose-dependente. Perdeu espaço para noradrenalina (SOAP-II).
Nitroprussiato de Sódio (0,250 – 10,000 mcg/kg/min) 1 amp (50 mg / 2 mL) + SF/SG5% 248 mL → Total: 5,3 – 250 mL (200 mcg/mL K:3.33) 210,0 mL/h 2 amp (100 mg / 4 mL) + SG5% 246 mL → Total: 2,6 – 105,0 250 mL (400 mcg/mL) mL/h ⚠ PROTEGER DA LUZ. ⚠ Trocar soro e equipo de 8/8h. ⚠ Risco de intoxicação por tiocianato em uso > 48h.	Milrinona (0,375 – 0,750 mcg/kg/min) 2 amp (20 mg / 20 mL) + SG5%/SF 180 mL → Total: 15,8 – 31,5 200 mL (100 mcg/mL) mL/h 4 amp (40 mg / 40 mL) + SG5% 210 mL → Total: 9,8 – 19,7 250 mL (160 mcg/mL) mL/h 2 amp (20 mg / 20 mL) + SG5%/SF 80 mL → Total: 7,9 – 15,8 100 mL (200 mcg/mL) mL/h Inotrópico inodilatador. ⚠ Requer ajuste para função renal. Ataque: 50 µg/kg em 10 min.
Nitroglicerina (5,00 – 200,00 mcg/min) 1 amp (25 mg / 5 mL) + SG5% 245 mL → Total: 3,0 – 120,0 250 mL (100 mcg/mL) mL/h 2 amp (50 mg / 10 mL) + SF/SG5% 240 mL → Total: 1,5 – 250 mL (200 mcg/mL K:3.33) 60,0 mL/h 4 amp (100 mg / 20 mL) + SG5% 230 mL → Total: 0,8 – 30,0 250 mL (400 mcg/mL) mL/h ⚠ NÃO confundir com nitroprussiato! Tolerância em 24–48h. Dose não é peso-dependente.	
Adrenalina (Infusão) (0,010 – 1,000 mcg/kg/min) 6 amp (6 mg / 6 mL) + SF 0,9% 94 mL → Total: 1000,7 – 70,0 mL (60 mcg/mL K:1) mL/h 2 amp (2 mg / 2 mL) + SG5%/SF 248 mL → Total: 5,3 – 525,0 250 mL (8 mcg/mL) mL/h 10 amp (10 mg / 10 mL) + SG5%/SF 190 mL → Total: 200 mL (50 mcg/mL) 0,8 – 84,0 mL/h 20 amp (20 mg / 20 mL) + SG5%/SF 180 mL → Total: 200 mL (100 mcg/mL) 0,4 – 42,0 mL/h 20 amp (20 mg / 20 mL) + SG5%/SF 80 mL → Total: 0,2 – 21,0 100 mL (200 mcg/mL) mL/h ⚠ NÃO confundir com a dose de PCR. Bradicardia: usar 2,5–12 mL/h na sol. 50µg/mL.	

SEDAÇÃO

SEDAÇÃO CONTÍNUA (VM)

Fentanil (0,700 – 10,000 mcg/kg/h)

2 amp (1 mg / 20 mL) + SG5%/SF 80 mL → Total: 4,9 – 70,0 mL/h

100 mL (10 mcg/mL)

4 amp (2 mg / 40 mL) + SF 0,9% 160 mL → Total: 4,9 – 70,0 mL/h

200 mL (10 mcg/mL)

4 amp (2 mg / 40 mL) + SG5% 60 mL → Total: 100 2,5 – 35,0 mL/h

20 mL (20 mcg/mL)

6 ampolas (500 µg / 10 mL) = 3000 µg em 60 mL 1,0 – 14,0 mL/h

→ 50 µg/mL

⚠ Rigidez torácica se bolus rápido. Naloxona é o antídoto.

Dexmedetomidina (0,200 – 0,700 mcg/kg/h)

2 amp (400 mcg / 4 mL) + SF 0,9% 96 mL → Total: 3,5 – 12,3 mL/h

100 mL (4 mcg/mL)

⚠ SEM depressão respiratória relevante. ⚠ Bradicardia/hipotensão. Ótima para desmame de VM. Ataque: 1 µg/kg em 10 min.

Midazolam (Infusão) (0,020 – 0,300 mg/kg/h)

2 amp (100 mg / 20 mL) + SF 0,9% 80 mL → Total: 0,0 – 0,0 mL/h

100 mL (1 mg/mL)

4 amp (200 mg / 40 mL) + SF 0,9% 160 mL → Total: 0,0 – 0,0 mL/h

200 mL (1 mg/mL)

8 amp (400 mg / 80 mL) + SG5% 120 mL → Total: 0,0 – 0,0 mL/h

200 mL (2 mg/mL)

6 ampolas (50 mg / 10 mL) = 300 mg em 60 mL → 0,0 – 0,0 mL/h

5000 µg/mL

⚠ Depressão respiratória dose-dependente. A ampola de 50mg/10mL é a mais usada p/ BIC.

Propofol (Infusão) (1,50 – 4,50 mg/kg/h)

Frasco ampola 20 mL a 1% (10 mg/mL). Usar 3 10,5 – 31,5 frascos = 60 mL mL/h

⚠ Hipotensão. ⚠ Síndrome da infusão do propofol se > 48h ou doses altas. Estabilidade 12h.

Cetamina (Infusão) (2,00 – 7,00 mcg/kg/min)

1 amp (500 mg / 10 mL) + SF 0,9% 490 mL → 8,4 – 29,4 mL/h

Total: 500 mL (1 mg/mL)

1 amp (500 mg / 10 mL) + SG5%/SF 240 mL → 4,2 – 14,7 mL/h

Total: 250 mL (2 mg/mL)

Boa estabilidade hemodinâmica. Broncoespasmo grave: 0,15–2,5 mg/kg/h. ⚠ Sialorreia, alucinações.

Remifentanil (0,050 – 0,200 mcg/kg/min)

1 frasco (2 mg) + SF/SG5% 100 mL → 20 10,5 – 42,0 µg/mL mL/h

2 frascos (2 mg) + SF/SG5% 100 mL → 40 5,3 – 21,0 µg/mL mL/h

1 frasco (5 mg) + SF/SG5% 100 mL → 50 µg/mL 4,2 – 16,8 mL/h

⚠ Meia-vida curta (3–5 min). Suspende se hipotensão. ⚠ Rigidez torácica se bolus.

INTUBAÇÃO (RSI)

RSI — BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR

Rocurônio (0,600 – 1,200 mg/kg)

10 mg/mL (ampola 50mg/5mL) 4,2 – 8,4 mL

Alternativa não-despolarizante segura. Reversão: sugamadex. Duração 30–45min.

Cisatracúrio (0,100 – 0,200 mg/kg)

2 mg/mL (ampola 5 ou 10mL) 3,5 – 7,0 mL

Eliminação de Hofmann (independente de fígado/rins). Escolha em hepatopatas/nefropatas.

BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR (CONTÍNUO)

Rocurônio (Infusão) (0,480 – 0,720 mg/kg/h)

4 amp (200 mg / 20 mL) + SF 0,9% 80 mL → 16,8 – 25,2 mL/h

Total: 100 mL (2 mg/mL)

2 amp (100 mg / 10 mL) + SF/SG5% 190 mL → 67,2 – 100,8 mL/h

Total: 200 mL (0,50 mg/mL)

Reversão: sugamadex. ⚠ Monitorar grau de bloqueio (TOF).

Cisatracúrio (Infusão) (1,00 – 3,00 mcg/kg/min)

2 ampolas (10 mg / 5 mL) + SG5%/SF 50 mL = 60 4,2 – 12,6 mL → 1000 µg/mL mL/h

2 ampolas (10 mg / 5 mL) + SG5%/SF 80 mL = 90 10,5 – 31,5 mL → 400 µg/mL mL/h

Eliminação de Hofmann (independente de fígado/rins). Escolha em hepatopatas/nefropatas.

☐ CHECKLIST RSI

- | | |
|--|---|
| ☐ Indicação de IOT confirmada | ☐ Equipamento verificado (laringoscópio, tubo, cuff, fixador, aspiração) |
| ☐ Monitorização: ECG, SpO ₂ , PANI, capnografia | ☐ Acesso venoso calibroso |
| ☐ Pré-oxigenação (10 min / 8 CVs com reservatório) | ☐ Medicação preparada e identificada |
| ☐ Posicionamento: rampa / olfativo | ☐ Pressão cricoide (Sellick) — controverso, discutir com equipe |
| ☐ Sedação + Bloqueador (sequência rápida) | ☐ Passagem do tubo — cuff insuflado |
| ☐ Confirmação: capnografia (ondas) + ausculta + elevação torácica | ☐ Pós-intubação: fixação, RX tórax, iniciar VM |

ACLS / RESSUSCITAÇÃO

ACLS / RESSUSCITAÇÃO

Amiodarona (150,00 – 300,00 mg IV)

SG5% 232mL + 18mL (3,6 mg/mL)

Acesso profundo: SG5% 222mL + 900mg

Acesso periférico: SG5% 482mL + 900mg

⚠ Diluir em SG5% (precipita em SF!). ⚠ Risco de flebite em acesso periférico. Regime SCCD: 16mL/h por 6h, depois 8mL/h por 18h.

OUTRAS

OUTRAS

Insulina Regular (IV) (0,500 – 5,000 UI/h)

1 mL de Insulina Regular (100 UI/mL) + SF 99 mL 0,5 – 5,0
= 100 mL → 1 UI/mL mL/h

⚠ Adsorve ao plástico do equipo — lavar antes de usar. ⚠ Monitorizar glicemia de 1/1h.

NaCl 3% (1,00 – 2,00 mL/kg/h)

SF 390mL + NaCl 10% 110mL (BIC 15mL/h) 70,0 – 140,0 mL/h

SF 445mL + NaCl 20% 55mL 70,0 – 140,0 mL/h

⚠ NÃO confundir com SF 0,9% ou NaCl 20%! ⚠ Risco de mielinólise pontina se correção rápida de Na⁺. Correção máx: 6–10 mEq em 24h (1 mL/kg aumenta 1 mEq/L sérico).

Flumazenil (Lanexat) (0,100 – 0,200 mg IV)

Amp 0,5mg/5mL – diluir p/ 10mL AD (0,05 mg/mL)

Antagonista de benzodiazepínicos. Inicial: 0,2 mg IV lento. Subsequentes: 0,1 mg a cada 1 min.

Naloxona (Narcan) (0,040 mg/mL)

Amp 0,4mg/1mL – diluir p/ 10mL AD (0,04 mg/mL)

Antagonista de opiídeos. 5 a 10 mL da solução diluída a cada 2–3 min.

Lidocaína (Xilocaína) (1,00 – 4,00 mg/min)

8 amp (800 mg / 40 mL) + SG5%/SF 60 mL → Total: 7,5 – 30,0
100 mL (8 mg/mL) mL/h

Tabela BIC: 7,5mL/h = 1mg/min · 15mL/h = 2mg/min · 22,5mL/h = 3mg/min · 30mL/h = 4mg/min.

Fenitoína (Hidantal) (15,00 – 20,00 mg/kg)

Amp 250mg/5mL – diluir em SF 0,9% 21,0 – 28,0 mL

Correr em 1h. ⚠ Não exceder velocidade de 250 mg a cada 15 min. ⚠ NÃO diluir em SG5% (precipita).

Furosemida (Lasix) (10,00 – 40,00 mg/h)

5 amp (100 mg / 10 mL) + SG5% 90 mL → Total: 10,0 – 40,0
100 mL (1 mg/mL) mL/h

10 amp (200 mg / 20 mL) + SG5% 80 mL → Total: 5,0 – 20,0
100 mL (2 mg/mL) mL/h

Ataque: 1–1,5 mg/kg IV. Manutenção: 10–40 mg/h em BIC.

Tirofiban (Agrastat) (0,100 – 0,400 mcg/kg/min)

1 frasco de 50 mL (250 µg/mL) + SG5%/SF 200 mL 8,4 – 33,6
= 250 mL → 50 µg/mL mL/h

Ataque: 0,4 µg/kg/min por 30 min. Manutenção: 0,1 µg/kg/min durante 12–42h.

Solução Polarizante (1,00 dose)

SG5% 400mL + SG50% 100mL + Insulina 10 UI

Padrão: EV em 1 hora. Separada/BIC: Glicose 60mL/h + Insulina 10mL/h.

NaCl 0,45% (Meio Fisiológico) (1,00 dose)

ABD 500mL + SF 500mL

ABD 955mL + NaCl 10% 45mL

ABD 977mL + NaCl 20% 23mL

Solução hipotônica. Usar com cautela em pacientes com risco de HIC.

NaCl 0,225% (Quarto de Fisiológico) (1,00 dose)

SF 250mL + ABD 750mL

ABD 977mL + NaCl 10% 23mL

ABD 989mL + NaCl 20% 11mL

Solução bastante hipotônica. ⚠ Risco de hemólise se infundido rapidamente.